

El suicidio desciende en España en 2024 pero sigue siendo la segunda causa de muerte externa, el estudio AIJU 2025/2026 alerta sobre el uso excesivo de pantallas en la infancia y la Sociedad Española de Neurología publica un consenso sobre prevención de la demencia: claves del 29 de agosto de 2026



SÁBADO 29 DE AGOSTO DE 2026

Resumen rápido del día

El Instituto Nacional de Estadística confirma un descenso del 4,0% en las muertes por suicidio en España durante 2024, aunque la cifra, 3.953 fallecimientos, mantiene este fenómeno como la segunda causa de muerte externa del país. El estudio AIJU 2025/2026 revela que el 95% de los médicos y el 93% de las familias españolas perciben efectos negativos del uso excesivo de pantallas en el desarrollo infantil. La Sociedad Española de Neurología publica un documento de consenso sobre los factores de riesgo modificables del deterioro cognitivo y la demencia. Un estudio en Psicothema documenta que los pacientes derivados a Psicología Clínica en la sanidad pública esperan una mediana de 51 días para la primera consulta, un plazo asociado al abandono temprano del tratamiento.

SALUD PÚBLICA · NACIONAL

El suicidio desciende un 4,0% en España en 2024, pero sigue siendo la segunda causa de muerte externa

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado su Estadística sobre defunciones según causa de muerte correspondiente a 2024, según recoge Infocop. En España se produjeron ese año 18.351 fallecimientos por causas externas, de los cuales 3.953 corresponden a suicidios, un 4,0% menos que en 2023. Pese a este descenso, el suicidio se mantiene como la segunda causa externa de muerte, por detrás de las caídas accidentales (4.450 fallecidos), con una tasa de 8,1 muertes por cada 100.000 habitantes. El fenómeno afecta predominantemente a los hombres, que representan alrededor del 75% de los casos (2.902 fallecidos, primera causa externa de muerte en este grupo), frente a 1.051 mujeres (tercera causa externa en ellas). El tramo de edad con mayor incidencia es el de 45 a 60 años, que concentra uno de cada tres suicidios. Un dato preocupante es que el suicidio en menores de 20 años alcanzó en 2024 su cifra más alta de los últimos años, con 90 casos, 14 más que el año anterior y por encima de los 87 registrados en 2022; a ello se suman 120 fallecimientos entre los 20 y los 24 años. Los municipios pequeños, de menos de 10.000 habitantes, presentan tasas más altas (9,3 por 100.000) que las capitales de provincia (7,5). El INE recuerda que la tendencia había sido creciente entre 2020 y 2022, coincidiendo con la pandemia, y que desde 2023 vuelve a descender. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó en febrero de 2025 el primer Plan de Acción para la Prevención del Suicidio (2025-2027).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), según recoge Infocop

SALUD PÚBLICA · NACIONAL

El uso excesivo de pantallas en la infancia preocupa a médicos y familias, según el estudio AIJU 2025/2026

El Instituto Tecnológico de Producto Infantil y Ocio (AIJU), en colaboración con la Fundación Crecer Jugando, ha publicado la 35ª edición de su Guía del juguete, centrada en esta ocasión en el impacto de la sobreexposición a pantallas en la salud y el desarrollo infantil, según recoge Infocop. El estudio contó con la participación de 65 médicos y médicas especialistas en infancia y 334 familias con hijos e hijas de 0 a 17 años. El 95% de los profesionales sanitarios y el 93% de las familias coinciden en que el uso excesivo de pantallas afecta negativamente al desarrollo infantil, y el 81% de los profesionales indica haber observado un aumento de problemas asociados. Entre los problemas de salud más frecuentes señalados por los pediatras figuran los trastornos del sueño (81%), problemas relacionados con la salud mental (69%), sobrepeso u obesidad (63%), retrasos en el desarrollo motor (25%), problemas de visión (19%) y problemas neurológicos (16%). Los y las profesionales de la psicología consultados señalan específicamente irritabilidad (75%), dificultades de socialización (67%), ansiedad y estrés (67%) y depresión (20%). El informe destaca que el 98% de los niños y niñas no cumple el criterio de la Asociación Española de Pediatría de cero pantallas hasta los 6 años. El 68% de las familias expresa preocupación por el tiempo que sus hijos e hijas pasan frente a los dispositivos y, aunque el 96% establece normas de uso, el 71% reconoce dificultades para mantenerlas.

Fuente: Instituto Tecnológico de Producto Infantil y Ocio (AIJU), según recoge Infocop

NEUROCIENCIA · NACIONAL

La Sociedad Española de Neurología publica un documento de consenso sobre prevención del deterioro cognitivo y la demencia

La revista Neurología ha publicado el documento de consenso de la Sociedad Española de Neurología (SEN) sobre prevención del deterioro cognitivo y la demencia, elaborado por un grupo de expertos en patología cognitiva junto con el Grupo de Estudio de Neurogeriatría de la propia sociedad, con Gil Moreno y colaboradores como firmantes. El texto, elaborado a partir de una revisión de la bibliografía existente, tiene como objetivo principal servir de guía a los y las profesionales de la salud con interés en el deterioro cognitivo y la demencia. El documento enumera los distintos factores de riesgo modificables relacionados con el estilo de vida que se han asociado en estudios recientes al desarrollo de

deterioro cognitivo y demencia, analiza aspectos relacionados con estos factores y propone una serie de recomendaciones básicas dirigidas a la práctica clínica. Entre los apartados que desarrolla se incluyen la prevención de la demencia propiamente dicha, la deprescripción de fármacos en este contexto, una revisión de los estudios de intervención multidominio disponibles y de las guías de prevención existentes. Los autores concluyen que la prevención de la demencia es posible mediante un enfoque de salud pública que incluya la implementación de intervenciones clave capaces de retrasar o ralentizar la aparición del deterioro cognitivo o la demencia, y presentan el documento como una herramienta útil para la práctica clínica de los y las profesionales dedicados a esta área.

Fuente: Sociedad Española de Neurología (SEN), revista Neurología (Elsevier)

Publicaciones científicas recientes

Miras-Aguilar, M. del M., Ruiz-Gutiérrez, J., Martínez-Gómez, S., Pérez-GarcíaAbad, S., Ramos-Barrón, C., Pariente-Rodrigo, E., Piñán-Setién, L., Otero-Cabanillas, N., Priede, M. I., & González-Blanch, C. (2026). Waiting times in clinical psychology in public mental health units: Predictors of attendance at the first appointment and early dropout. *Psicothema*, 38(1), 13–22.

<https://doi.org/10.70478/psicothema.2026.38.02>

DOI: [10.70478/psicothema.2026.38.02](https://doi.org/10.70478/psicothema.2026.38.02)

Hallazgo: Estudio observacional retrospectivo con 2.765 pacientes mayores de 18 años derivados desde Atención Primaria a cuatro Unidades de Salud Mental del área de Santander (Cantabria) durante 2021. Mediante regresiones logísticas y curvas ROC, los autores analizaron la influencia de los tiempos de espera en la asistencia a la primera cita y en el abandono temprano del tratamiento. La mediana del tiempo de espera fue de 51 días para la primera consulta y de 35 días entre la primera y la segunda. El 84,6% de los pacientes asistió a la primera cita, siendo más probable en mujeres, personas de mayor edad, con incapacidad laboral temporal y con menor tiempo de espera. El abandono temprano, registrado en el 15,8% de quienes recibieron una segunda cita, se asoció con un mayor tiempo entre consultas, con ser hombre y con una menor edad; el poder discriminativo de los puntos de corte identificados mediante las curvas ROC fue, según los propios autores, pobre.

Implicación clínica: Los autores concluyen que los tiempos de espera exceden las recomendaciones clínicas y comprometen la continuidad del tratamiento psicológico. Plantean que sería necesaria una revisión estructural del sistema, con más recursos humanos en Psicología Clínica y una mejor coordinación entre Atención Primaria y las Unidades de Salud Mental, y sugieren que modelos de atención escalonada podrían contribuir a optimizar el uso de los recursos disponibles.

Herramientas clínicas e instrumentos

- **Sistemas de control parental y gestión del tiempo de pantalla:** Funciones y aplicaciones, disponibles de forma nativa en la mayoría de sistemas operativos, que permiten a las familias establecer límites de tiempo de uso, filtrar contenidos y supervisar la actividad digital de niños, niñas y adolescentes.
- **Plataformas de estimulación cognitiva digital validadas para uso clínico:** Programas informáticos orientados al entrenamiento y la estimulación de funciones cognitivas como la memoria, la atención o el lenguaje en personas con deterioro cognitivo, que permiten personalizar los ejercicios y hacer seguimiento de la evolución desde la consulta.

Prioridades del día

Acompañar a las familias en la gestión del tiempo de pantalla

A la luz del estudio AIJU 2025/2026, puede ser útil explorar con las familias el establecimiento de rutinas de juego sin pantallas y revisar de forma conjunta el grado de cumplimiento de las recomendaciones de exposición digital por edad.

Incorporar los factores de riesgo modificables en la valoración neuropsicológica

Puede ser relevante revisar en la anamnesis los factores de riesgo modificables relacionados con el estilo de vida que señala el documento de consenso de la SEN, especialmente en personas mayores con antecedentes cardiovasculares o con aislamiento social.

Sostener la alianza terapéutica ante demoras de derivación

Puede ser oportuno anticipar a los pacientes derivados desde el sistema público la posibilidad de esperas prolongadas entre consultas y reforzar, desde la consulta privada o de apoyo, estrategias que sostengan la motivación durante ese intervalo, en línea con lo que sugiere el estudio publicado en Psicothema.